

1. Introducción y relevancia clínica

La **parálisis de cuerdas vocales (PCV)** es la **pérdida parcial o completa del movimiento** de una o ambas cuerdas vocales, debido a una lesión o alteración del **nervio laríngeo recurrente (NLR)** o del **nervio laríngeo superior**.

Esta patología tiene **gran relevancia clínica** por su impacto en tres funciones críticas:

1. **Fonación (voz)** → disfonía o afonía.
2. **Protección de vía aérea** → riesgo de aspiración.
3. **Respiración** → disnea o estridor si bilateral.

Epidemiología

- La **parálisis unilateral** es más frecuente que la bilateral.
- El **nervio laríngeo recurrente izquierdo** se afecta con mayor frecuencia (trayecto más largo).
- Causas más comunes:
 - **Iatrogénica** (cirugía tiroidea, carotídea o mediastínica).
 - **Neoplásica** (pulmón, tiroides, esófago, mediastino).
 - **Idiopática** (hasta 30% de los casos).

Relevancia clínica

- La PCV puede ser **manifestación inicial de tumores torácicos o cervicales**, especialmente **cáncer de pulmón o tiroides**.
- Su diagnóstico precoz y manejo multidisciplinario son esenciales para preservar la voz y prevenir aspiraciones.
- Es un tema clásico en el **EUNACOM**, tanto en su **etiología postquirúrgica** como en el **diagnóstico funcional y manejo ORL**.

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Anatomía funcional

El **nervio laríngeo recurrente (NLR)** es una rama del **nervio vago (X)**:

- El **derecho** rodea la arteria subclavia y asciende por el surco traqueoesofágico.
- El **izquierdo** rodea el arco aórtico y asciende más medialmente, lo que lo hace más vulnerable a lesiones mediastínicas.

El NLR **inerva todos los músculos intrínsecos de la laringe**, excepto el **cricotiroideo** (inervado por el nervio laríngeo superior).

Su función:

- **Aducción** de las cuerdas (cierre glótico durante fonación y deglución).
- **Abducción** (apertura para la respiración).

2.2 Fisiopatología

- La lesión nerviosa puede ser **neuropraxia (transitoria)**, **axonotmesis** o **neurotmesis** (sección completa).
- La cuerda vocal afectada **pierde movilidad** y queda generalmente en **posición paramediana o intermedia**.
- En parálisis bilateral, ambas cuerdas pueden quedar **casi en línea media**, causando **disnea inspiratoria grave**.

La **recuperación nerviosa** depende de la causa y puede tardar **hasta 6–12 meses**.

2.3 Etiología

Causa

Ejemplos

Iatrogénica (más frecuente)	Cirugía tiroidea, cervical, carotídea, mediastínica, intubación prolongada.
Neoplásica	Cáncer de tiroides, pulmón (ápice o mediastino), esófago, laringe.
Neurológica	Accidente cerebrovascular bulbar, esclerosis lateral amiotrófica, trauma craneocervical.
Infecciosa / inflamatoria	Neuritis viral, tuberculosis, sarcoidosis.
Idiopática	Hasta 30% de los casos; posible origen viral o microvascular.

3. Clínica (signos, síntomas, diagnóstico diferencial)

3.1 Parálisis unilateral

- **Síntoma principal: disfonía** (voz soplada, débil, fatigable).
- Otros:
 - Tos inefectiva.
 - Aspiración de líquidos (por cierre glótico incompleto).
 - Disnea leve en esfuerzo.
- **Compensación:** la cuerda contralateral puede adaptarse con tiempo.

3.2 Parálisis bilateral

- **Disnea inspiratoria o estridor**, especialmente en reposo.
- Voz puede estar relativamente conservada (por cierre glótico casi completo).

- Alto riesgo de **asfixia aguda**.
 - Puede requerir **traqueostomía urgente**.
-

3.3 Examen físico

- Voz soplada, ronca o afónica.
 - Tos débil, con escape de aire.
 - En casos graves: tiraje y estridor inspiratorio.
 - Movilidad de cuerdas evaluada con laringoscopia: una o ambas inmóviles.
-

3.4 Diagnóstico diferencial

Entidad	Diferencias clave
Laringitis crónica	Inflamación mucosa, pero con movilidad conservada.
Disfonía funcional	Cuerdas móviles, sin lesión estructural.
Tumor glótico	Lesión visible en cuerda o comisura anterior, puede coexistir con inmovilidad.
Fijación cricoaritenoides	Cuerda inmóvil, pero nervio intacto (evaluar con EMG laríngea).
Estenosis subglótica	Estridor, pero cuerdas móviles.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Evaluación inicial

- **Anamnesis dirigida:**
 - Cirugías previas (tiroides, tórax).
 - Tabaco, disnea, aspiración.
 - Evolución temporal.
 - **Examen físico:**
 - Inspección del cuello.
 - Evaluación de voz y reflejo tusígeno.
-

4.2 Evaluación otorrinolaringológica

Examen	Utilidad
Laringoscopia flexible	Evalúa posición y movilidad de las cuerdas vocales. Determina si la parálisis es unilateral o bilateral.
Videolaringoestroboscopia	Estudia vibración mucosa y compensación glótica.
Electromiografía laríngea (EMG)	Diferencia parálisis verdadera de fijación articular. Predice recuperación nerviosa.

4.3 Estudios etiológicos complementarios

Según sospecha clínica:

- **TAC cuello y tórax** → descarta lesión compresiva en trayecto del nervio (mediastino, pulmón, tiroides).
- **RM encéfalo y base del cráneo** → si se sospecha causa central.

- **Ecografía tiroidea** → en sospecha de patología cervical.
 - **Laringoscopia directa bajo anestesia** → en casos quirúrgicos o diagnóstico incierto.
-

4.4 Criterios diagnósticos

Se confirma **parálisis de cuerda vocal** cuando:

1. Hay **disfonía o disnea persistente**.
 2. La **laringoscopia muestra inmovilidad** de una cuerda (o ambas).
 3. No se evidencia lesión mecánica o inflamatoria que lo explique.
 4. Se demuestra **lesión del nervio laríngeo recurrente o superior** como causa subyacente.
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL / Chile)

5.1 Enfoque general

Depende de:

- **Lateralidad (uni o bilateral).**
- **Duración y causa.**
- **Grado de disfunción respiratoria o aspirativa.**

El manejo debe ser **multidisciplinario**: ORL, fonoaudiólogo, neurólogo y, en ocasiones, cirujano torácico.

5.2 Parálisis unilateral

Manejo inicial

- Observar hasta **6 meses**, ya que puede haber recuperación espontánea.

- **Terapia fonoaudiológica:** reeducación vocal, compensación respiratoria y glótica.
- **Control ORL** cada 2–3 meses con videolaringoscopia.

Tratamiento definitivo

Si no hay recuperación o hay aspiración persistente:

1. **Inyección de medialización** (Teflón, ácido hialurónico o grasa autóloga):
 - Aumenta masa de la cuerda paralizada.
 - Mejora cierre glótico y voz.
2. **Tiroplastia tipo I (medialización laríngea):**
 - Colocación de implante (silicona o titanio) en el cartílago tiroides.
 - Procedimiento permanente.
3. **Reinervación laríngea selectiva (ansahipogloso):**
 - En centros especializados; resultados funcionales excelentes.

5.3 Parálisis bilateral

- **Emergencia potencial.**
- Evaluar **compromiso respiratorio:**
 - Si estridor o hipoxemia → **traqueostomía inmediata.**
- Si respiración estable:
 - Observación y eventual cirugía reconstructiva (cordotomía, aritenoidectomía láser).
 - Terapia de voz y foniatría.

En casos irreversibles, puede considerarse **traqueostomía definitiva** o **recanalización endoscópica.**

5.4 Tratamiento etiológico

- **Resección de tumores compresivos** (tiroides, mediastino).
 - **Rehabilitación neurológica** en parálisis post-ACV.
 - **Retiro de tubos endotraqueales** prolongados si son causa.
 - **Evitar reintubación traumática.**
-

6. Complicaciones y pronóstico

6.1 Complicaciones

- **Aspiración broncopulmonar** (por cierre glótico incompleto).
 - **Neumonía aspirativa.**
 - **Disnea o estridor severo** (bilateral).
 - **Atrofia muscular laríngea.**
 - **Fracaso de medialización o recurrencia de la disfonía.**
-

6.2 Pronóstico

- En **parálisis unilateral**, recuperación espontánea hasta en 30–40% de los casos.
 - Con **rehabilitación vocal y medialización**, la mayoría recupera una voz funcional.
 - En **bilateral**, el pronóstico depende del control de la vía aérea.
 - **Parálisis postquirúrgicas** pueden ser permanentes, pero funcionalmente compensadas con tratamiento.
-

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas

1. **Disfonía persistente >3 semanas en paciente operado de tiroides → sospechar lesión del NLR.**
 2. La **parálisis unilateral** produce **voz soplada** y **aspiración de líquidos**.
 3. La **parálisis bilateral** causa **estridor inspiratorio** y puede requerir traqueostomía urgente.
 4. **Laringoscopia flexible** es el examen diagnóstico inicial.
 5. En parálisis unilateral, el **tratamiento inicial es fonoaudiología**, y luego **medialización** si no hay recuperación.
 6. Siempre descartar **tumor pulmonar o mediastínico izquierdo** en PCV izquierda idiopática.
 7. La **voz puede mejorar notablemente con terapias de rehabilitación vocal**, incluso sin cirugía.
-

Errores comunes

- No derivar a ORL una disfonía postquirúrgica.
 - Omitir estudio torácico en parálisis izquierda.
 - Intentar intubación repetida en paciente con estridor por PCV bilateral.
 - Confundir disfonía funcional con parálisis verdadera.
 - Realizar cirugía precoz sin esperar recuperación neurológica espontánea.
-

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. La **parálisis de cuerdas vocales** es causada por lesión del **nervio laríngeo recurrente o superior**.
2. **Causa más frecuente:** iatrogénica (cirugía tiroidea o torácica).

3. **Clínica:** disfonía, tos inefectiva y aspiración (unilateral); disnea y estridor (bilateral).
4. **Diagnóstico:** laringoscopia flexible + estudio de extensión (TAC cuello y tórax).
5. **Tratamiento:** fonoaudiología inicial; medialización o tiroplastia si no hay recuperación.
6. En parálisis bilateral con compromiso respiratorio → **traqueostomía de urgencia.**
7. Pronóstico generalmente bueno con rehabilitación y cirugía adecuada.